



Precificação Estruturada da Jornada Cirúrgica: Evidências de Saving em 4.800 Protocolos na Saúde Suplementar

Edição 005/2026 | 07 de junho de 2026 | Publicado



Grupo CSV — Cuidados em Saúde com Valor

1. Contexto: A Pressão Financeira no Mercado Cirúrgico Privado

O mercado de saúde suplementar brasileiro realizou 3,3 milhões de cirurgias em 2024 nos hospitais associados à Anahp. Este volume ocorre em um setor onde as despesas assistenciais totais atingiram R\$ 273 bilhões e a margem EBITDA hospitalar recuou para 10,7% no segundo trimestre de 2025. Neste cenário, a glosa inicial avançou de 7,26% (1º trimestre de 2023) para 17% (1º trimestre de 2025), enquanto a inflação médica registrou 16,9% em 2025 [1].

Operadoras e hospitais negociam o evento cirúrgico sem que nenhum dos lados disponha do custo real da jornada como instrumento de contratação. O diagnóstico convencional atribui essa deterioração à assimetria de poder de negociação e à defasagem das tabelas. Contudo, há um mecanismo estrutural anterior: operadoras remuneram por item, sem visibilidade do custo total, e hospitais custeiam por departamento, sem visibilidade do custo por procedimento. O resultado é um mercado que negocia seu componente de maior complexidade financeira sem uma base técnica comum.

2. Síntese: A Precificação da Jornada Cirúrgica Completa

A análise de 4.800 protocolos cirúrgicos precificados [1] demonstra que a ausência de um custo de referência tem um impacto mensurável: o saving por evento varia entre R\$ 500 e R\$ 3.000, crescendo conforme a presença e o peso de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME). A precificação da jornada cirúrgica completa transforma o evento de um custo variável não gerenciável em uma unidade de análise econômica precisa.

O saving gerado não é produto de corte assistencial, mas sim da eliminação da variação injustificada de conduta e da substituição da aquisição fragmentada pela padronização por protocolo. O protocolo precificado não é o saving em si; é o instrumento que torna a ineficiência visível e gerenciável.

3. Implicações: Os Vetores do Saving Estrutural

Dois vetores independentes respondem pelo saving estrutural quando a jornada é precificada como protocolo completo [1]:

- Padronização de Insumos (66% do saving): O modelo fee-for-service (conta aberta) elimina o incentivo econômico para padronizar insumos. Quando a transição para pacotes ocorre sem a prévia padronização, o resultado é prejuízo imediato. Hospitais sem protocolo operam com custo até 40% superior em cirurgias com OPME.
- Tipo de Protocolo Adotado (34% do saving): A escolha estruturada do protocolo atua diretamente sobre o custo unitário por evento, preservando a qualidade assistencial.

A escala do saving é diretamente proporcional à complexidade e ao uso de OPME:

- Baixa complexidade (sem OPME): R\$ 500 por evento.
- Média e alta complexidade (sem OPME): R\$ 1.200 por evento.
- Alta complexidade (com OPME de grande porte): R\$ 2.000 por evento.
- Hemodinâmica e vascular: R\$ 3.000 por evento (onde OPME representa até 82% do custo total).

Para as operadoras, que concentram R\$ 102,7 bilhões (40% do total) das despesas assistenciais em internações (apenas 0,47% do volume), o protocolo precificado resolve o risco de severidade. Em um caso documentado, uma operadora com 70 mil beneficiários obteve um saving de R\$ 32 milhões em 13 meses após adotar 450 protocolos de alto custo [1].

Para os hospitais, a precificação estruturada reverte o déficit operacional do centro cirúrgico. Um hospital de 180 leitos implantou 872 protocolos precificados, revertendo sua margem de -16% para +14% em 16 meses, com R\$ 12 milhões de saving acumulado [1].

4. Recomendações

Com base na análise dos 4.800 protocolos [1], recomenda-se:

5. Referências

[1] Estudo Base: Saving Cirúrgico Estrutural: O que 4.800 protocolos cirúrgicos precificados revelam sobre eficiência de custo para operadoras e prestadores. Evodux Intelligence, 07 de junho de 2026. (Análise primária que fundamenta integralmente os dados, valores e conclusões desta edição do Compass™).